



Collection MedWIZ

6^e année médecine

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Cours :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Otite moyenne aiguë	8				
02	Pathologies de l'oreille externe	12				
03	Otites chroniques	14				
04	Surdités	18				
05	Vertiges périphériques	22				
06	Épistaxis	26				
07	Obstruction nasale	28				
08	Sinusites aiguës et chroniques	30				
09	Angines et rhinopharyngites	34				
10	Tuméfactions cervicales	36				
11	Cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS)	40				
12	Dyspnées laryngées	44				
13	Traumatismes du cou	48				
14	Corps étrangers en ORL	52				

II. Travaux dirigés :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
15	Nez et sinus	58				
16	Technique de méchage en ORL	62				
17	Examen clinique et paraclinique des fosses nasales et des sinus	64				
18	Fractures des os propres du nez (OPN)	68				
19	Plaies cervico-faciales	70				
20	Traumatismes externes du cou	74				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Cours

© 2026 The WIZ. Tous droits réservés.

OTITE MOYENNE AIGUË (1)

I. DÉFINITION

- Inflammation aiguë des cavités de l'oreille moyenne (caisse du tympan, cellules mastoïdiennes, trompe auditive) consécutive à une rhinopharyngite.

II. ÉTIOPATHOGÉNIE

A. Mécanisme

- Infection résultant de l'interférence entre charge microbienne et réaction immunitaire.
- Survient le plus souvent dans un contexte de rhinopharyngite virale.

B. Facteurs favorisants

- Âge (nourrisson et jeune enfant).
- Prédisposition génétique.
- Atopie.
- Crèche.
- Fratrie.
- Saison automno-hivernale.

C. Rôle de la trompe d'Eustache

- Dysfonction tubaire secondaire à la rhinopharyngite :
 - œdème de la muqueuse tubaire.
 - obstruction de la trompe d'Eustache.
 - troubles de l'aération de l'oreille moyenne.
 - création d'un environnement favorable à la prolifération bactérienne.

D. Germes principaux

Germe	Particularités
<i>Haemophilus influenzae</i>	Le plus fréquent (surtout chez l'enfant)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Fréquent, potentiellement plus invasif
<i>Moraxella catarrhalis</i>	Fréquent, notamment chez le jeune enfant

III. DIAGNOSTIC (Clinique + Otoscopie)

A. Symptômes

- Otalgie brutale, intense.
- Fièvre.
- Otorrhée purulente (spontanée ou après perforation).
- Chez le nourrisson : équivalents cliniques possibles (irritabilité, pleurs, troubles du sommeil, refus alimentaire).

B. Stades otoscopiques

1. Stade congestif (phase initiale)

- Hyperhémie péri-malléaire.
- Tympan opaque, épaissi.
- Disparition du cône lumineux.

2. Stade collecté (suppuration)

- Tympan bombé, œdémateux.
- Aspect tendu, luisant.
- Douleur pulsatile.
- Épanchement purulent dans la caisse du tympan.

3. Stade perforé

- Perforation tympanique punctiforme (le plus souvent).
- Otorrhée purulente.
- Soulagement rapide de la douleur.
- Apyrexie (disparition de la fièvre).

IV. ÉVOLUTION

- Généralement favorable avec restitution *ad integrum* (guérison sans séquelle).
- Évolution spontanément favorable en quelques jours sous traitement adapté.
- Risque de complications en cas :
 - de terrain immunodéprimé.
 - de germe virulent.

OTITE MOYENNE AIGÜE (2)

V. COMPLICATIONS

A. LOCORÉGIONALES

1. Mastôidite

- Extension de l'infection aux cellules mastoïdiennes
- Douleur rétro-auriculaire, tuméfaction, rougeur
- Risque d'abcès sous-périosté

2. Paralysie faciale périphérique

- Atteinte du nerf facial dans l'oreille moyenne
- Survenue brutale, unilatérale
- Le plus souvent transitoire

3. Labyrinthite

- Extension de l'infection à l'oreille interne
- Vertiges intenses, troubles de l'équilibre
- Surdit  neurosensorielle
- Risque de s quelles auditives

B. ENDOCRÂNIENNES

1. M ningite

- Inflammation des m ninges
- C phal es, fi vre, raideur de nuque
- Urgence th rapeutique

2. Empy me extradural

- Collection purulente entre la dure-m re et la table interne du c r ne
- C phal es, fi vre
- Traitement chirurgical et antibiotique

3. Abc s c r bral

- Collection purulente intraparenchymateuse
- Signes neurologiques focaux, c phal es, fi vre
- Traitement chirurgical et antibiotique

4. Thrombophl bite du sinus lat ral

- Thrombose septique du sinus lat ral
- C phal es, fi vre,  d me papillaire possible
- Risque d'extension veineuse et d'embolies septiques

VI. TRAITEMENT

A. ANTIBIOTH RAPIE

- Amoxicilline ou amoxicilline-acide clavulanique
- Dose : 80 mg/kg/j
- Adaptation secondaire selon l' volution clinique et la tol rance

B. TRAITEMENTS ADJUVANTS

- Antalgiques : parac tamol (1  intention)
- Antipyr tiques
- D congestionnants nasopharyng s
- Gouttes auriculaires (antalgiques)

C. PARACENT SE

- Indiqu e si :
 - OMA hyperalgique
 - OMA rebelle au traitement m dical
 - OMA compliqu e
 - Nourrisson < 3 mois
 - Terrain immunod prim 
- Permet l' vacuation du pus et un pr l vement bact riologique
- Associ e   une antibioth rapie

D. DUR E

- 8 - 10 jours si  ge < 2 ans
- 5 jours si  ge ≥ 2 ans